

Szczepionki COVID: znane działania niepożądane i fałszywe mity



Szybka odpowiedź

Szczepionki przeciw COVID-19 mogą powodować działania niepożądane, ale profil zależy od konkretnej technologii, preparatu, wieku i płci. Po szczepionkach mRNA rozpoznano bardzo rzadkie zapalenie mięśnia sercowego lub osierdzia, najczęściej u młodszych mężczyzn. TTS wiązano bardzo rzadko ze szczepionkami wektorowymi AstraZeneca i Janssen. Jeśli zdarzenie wpisano do VAERS, samo zgłoszenie nie dowodzi przyczyny.

Kluczowe wnioski

- Ryzyka trzeba przypisywać do konkretnego preparatu i grupy, a nie do „wszystkich szczepionek”.
- Ból w klatce, duszność lub kołatanie po szczepieniu wymagają oceny, szczególnie w pierwszych dniach.
- TTS dotyczyło bardzo rzadkich zdarzeń po wybranych szczepionkach wektorowych, nie typowego zakrzepu po każdej szczepionce.
- VAERS służy do wychwytywania sygnałów; zgłoszenie może nastąpić bez potwierdzenia związku przyczynowego.

Jakie objawy po szczepieniu są częste, a które wymagają pomocy?

Ból w miejscu wkłucia, zmęczenie, ból głowy lub mięśni i gorączka zwykle są łagodne albo umiarkowane i ustępują w ciągu 1–3 dni. Pilnej oceny wymaga nasilony ból w klatce, duszność, omdlenie, utrzymujące się kołatanie, nowe objawy neurologiczne albo ciężka reakcja alergiczna. Rodzaj i czas objawów pomagają ocenić możliwą przyczynę.

Nie diagnozuj zapalenia serca samym tętnem z zegarka; przydatność urządzeń omawia [artykuł o pomiarach z Apple Watch](#).



Ból ręki, zmęczenie lub gorączka najczęściej mają krótki przebieg; nasilone albo nietypowe objawy wymagają oceny.

Co wiadomo o zapaleniu mięśnia sercowego po mRNA?

EMA uznaje zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia za bardzo rzadkie działanie szczepionek Comirnaty i Spikevax. Ryzyko było największe u młodszych mężczyzn, zwykle po drugiej dawce wcześniejszych schematów. Nie wolno przenosić tej częstości bezpośrednio na osobę po 50-tce ani na każdy aktualny preparat.

Decyzję o kolejnej dawce po potwierdzonym zapaleniu serca podejmuje lekarz według aktualnych zaleceń.

Jak to zastosować?

Przed oceną ryzyka zapisz nazwę preparatu, datę dawki, wiek i objawy. „Szczepionka COVID” to zbyt szeroka kategoria.



Ból w klatce, duszność lub kołatanie wymagają badania; zegarek ani sam opis objawów nie potwierdzą zapalenia serca.

Czym było TTS po szczepionkach wektorowych?

TTS łączy zakrzepicę w nietypowych lokalizacjach z małą liczbą płytek. EMA powiązała bardzo rzadkie przypadki z Vaxzevria i Jcovden. To odrębny zespół od typowej zakrzepicy żył głębokich i nie jest właściwe przypisywanie go szczepionkom mRNA bez danych.

Informacje historyczne trzeba czytać razem z nazwą preparatu; aktualną dostępność i zalecenia sprawdzaj w oficjalnych źródłach.



TTS łączył zakrzepicę z małą liczbą płytek, dlatego rozpoznanie wymagało obrazu klinicznego i badań krwi.

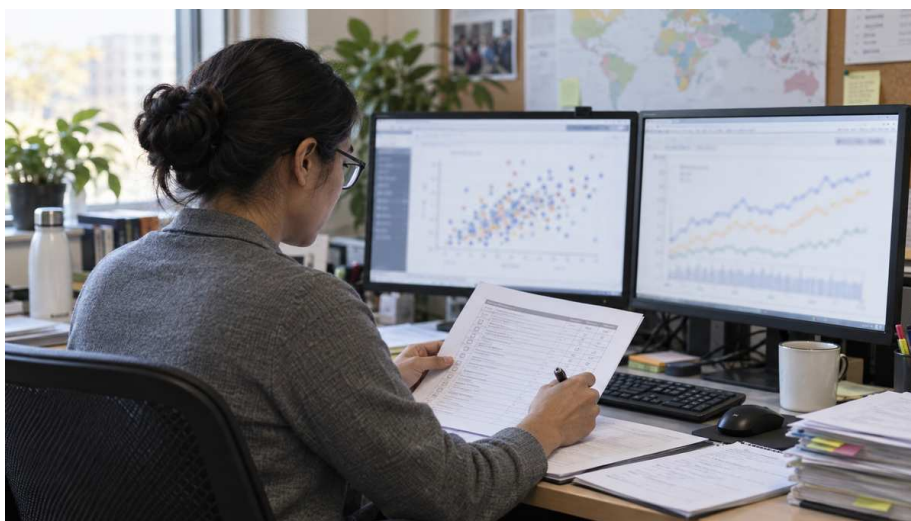
Dlaczego VAERS nie podaje liczby przypadków spowodowanych szczepieniem?

Do VAERS można zgłosić zdarzenie występujące po szczepieniu nawet bez dowodu, że szczepionka je wywołała. System pomaga wykrywać nietypowe wzorce, które następnie analizuje się z użyciem dokumentacji, porównania częstości i innych baz. Dzielenie liczby zgłoszeń przez liczbę dawek nie daje wiarygodnego ryzyka przyczynowego.

Zasady oceny źródeł i przekazów zdrowotnych rozwija [poradnik o mediach społecznościowych](#), [analiza mechanizmów strachu](#) oraz materiał o [ocenie korzyści i ryzyka szczepienia HPV](#).

Warunek bezpieczeństwa

Ból w klatce, duszność, omdlenie, ciężka reakcja alergiczna lub nowe objawy neurologiczne wymagają pilnej oceny.



Zgłoszenia pomagają wykrywać sygnały, ale związek przyczynowy ocenia się dopiero z użyciem dodatkowych danych i metod.

Jak interpretować zdarzenia po szczepieniu?

Sygnał	Co wiadomo?	Co zrobić?
Ból ręki i gorączka Ból w klatce lub duszność TTS Zgłoszenie VAERS	Częste, zwykle krótkie Może wymagać wykluczenia zapalenia serca Bardzo rzadkie po wybranych wektorowych Sygnał, nie dowód przyczyny	Obserwacja i zalecenia producenta Pilna ocena Ocena objawów i preparatu Sprawdzić analizę regulatora

Uczciwa rozmowa o bezpieczeństwie nie ukrywa działań niepożądanych i nie zamienia surowych zgłoszeń w dowód przyczynowy.

Najczęściej zadawane pytania

Czy szczepionka mRNA może wywołać zapalenie mięśnia sercowego?

Tak, jest to uznane bardzo rzadkie działanie, częstsze w określonych młodszych grupach. Objawy wymagają oceny.

Czy AstraZeneca powodowała zakrzepy?

EMA powiązała Vaxzevria z bardzo rzadkim zespołem TTS, który łączy nietypową zakrzepicę z małą liczbą płytek.

Czy wpis w VAERS oznacza skutek szczepionki?

Nie. Oznacza zdarzenie zgłoszone po szczepieniu; związek przyczynowy wymaga dalszej analizy.

Czy szczepionki wpływają na płodność?

Duże badania nie potwierdziły trwałego uszkodzenia płodności. Przejściowe zmiany cyklu nie są tym samym co bezpłodność.

Źródła

1. [EMA safety of COVID-19 vaccines](#)
2. [CDC VAERS data guide](#)
3. [A Systematic Review and Meta-analysis of the Association Between SARS-CoV-2 Vaccination and Myocarditis or Pericarditis](#)
4. [Patone i wsp. — Risks of myocarditis, pericarditis, and cardiac arrhythmias associated with COVID-19 vaccination or SARS-CoV-2 infection](#)
5. [CDC — działania niepożądane i zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19](#)
6. [CDC — szczepienie COVID-19, ciąża i płodność](#)

Uwaga: Artykuł ma charakter informacyjny i edukacyjny. Nie zastępuje konsultacji, diagnozy ani indywidualnego leczenia.